

02 - 02- Les Endométrioses - Pr. SOUMMANI

Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un chapitre concernant une pathologie gynécologique assez mystérieuse, surtout sur le plan étiopathogénique, c'est les endométrioses. L'endométriose se définit comme étant l'implantation et le développement en dehors de la cavité utérine du tissu endométrial. Ça veut dire que, en général, le tissu endométrial, l'endomètre, capisse la cavité de l'utérus.

Dans les endométrioses, le tissu endométrial se trouve à l'extérieur de la cavité utérine, que ce soit au niveau du myomètre, c'est-à-dire au niveau de la paroi musculaire lisse de l'utérus, et dans ce cas, l'endométriose est appelée endométriose interne ou adénomyose, ou bien le tissu endométrial se trouve en dehors de l'utérus, plus souvent au niveau du pelvis, mais il peut être implanté au niveau de la vessie, au niveau du sigmoïde, au niveau même du poumon, et dans ce cas, il est appelé endométriose externe. La définition de l'endométriose est une définition purement histologique, puisqu'il n'y a pas, jusqu'à maintenant, de définition clinique. On voit ici une échographie endovaginale d'un utérus normal, où il y a le myomètre, où il y a l'endomètre.

L'endomètre se trouve au niveau de la cavité, le myomètre c'est la paroi musculaire de l'utérus. A droite, on voit une vue stéréoscopique qui montre l'utérus, les trempes, le cul de sac de Douglas, et le verre gauche d'un côté et le verre droit, et en arrière, on voit le colon sigmoïde. Dans le schéma à gauche, c'est tout ce qui est normal, c'est l'endomètre qui est en rouge et qui se trouve à l'intérieur de la cavité de l'utérus.

Par contre, à droite, on voit un tissu endométriosique, que ce soit au niveau du vagin, c'est l'endométriose vaginale, ou bien au niveau de l'ovaire, c'est l'endométriose ovarienne, ou bien au niveau de la trompe, c'est l'endométriose tubaire. Sur le plan épidémiologique, l'endométriose, puisque l'endomètre n'est fonctionnel qu'en période d'activité génitale, donc cette pathologie ne concerne que les femmes en période d'activité génitale. Il faut savoir que 10 à 15% des femmes porteuses d'endométriose sont des femmes qui ne présentent aucun symptôme.

Plus de 30% de femmes infertiles ou des femmes qui présentent des douleurs péloriennes chroniques ont cette pathologie. C'est une pathologie de la femme de peau blanche et surtout, également, les femmes japonaises. Vous voyez que, puisqu'il y a beaucoup de cas qui sont asymptomatiques et que la définition est purement histologique, donc la prévalence de cette pathologie n'est pas bien connue.

Les facteurs de risque de la maladie sont d'abord les malformations utérines, puisque les malformations utérines s'accompagnent d'une sténose du col de l'utérus. Et par conséquent, ça c'est parmi une des théories, donc s'il y a une sténose du col, l'écoulement du saignement des règles vers la cavité vaginale ne va pas se faire. Il va se faire vers l'étrouque et vers le péritoine.

Le saignement des règles s'accompagne de débris endométriaux et ces débris peuvent

s'implanter ailleurs de la cavité utérine. Il faut dire que cette pathologie a un caractère héréditaire puisque les soeurs des femmes atteintes d'endométriose ont un risque d'endométriose sept fois plus élevé que les femmes de la population en général. Il y a également l'environnement, la dioxine qui est un produit qui se dégage par l'industrie et qui va jouer le rôle d'œstrogène laïque et qui peut causer cette pathologie.

Il y a également la présence d'aromatase et de prostaglandine E2 dans les cellules endométriosiques qui vont permettre la synthèse locale d'œstrogène et qui va bien sûr entraîner une entretenu automatique de ces débris endométriosiques. Il y a quatre théories étiopathogéniques. Je ne vais pas les détailler.

Il y a le reflux utéro-tubaire, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire lorsqu'il y a une sténose du col, le reflux des règles se fait vers la cavité pelvienne et par conséquent il y a l'implantation des débris endométriosiques en dehors de la cavité de l'utérus. Il y a également la métaplasie des cellules de l'épithélium cellulaire. Il y a la théorie mixte, c'est-à-dire associant le reflux utéro-tubaire à la métaplasie de cellules épithéliales cellulaires.

Et il y a la théorie métastatique, c'est-à-dire les débris de l'endomètre qui vont se métastaser à distance. C'est ce qui pourrait expliquer l'endométriose pulmonaire ou l'endométriose ailleurs de la cavité pelvienne. Sur le plan anatomopathologique, je vous ai dit que l'endométriose est une définition histologique et par conséquent vous ne pouvez faire le diagnostic de certitude qu'avec une biopsie qui va montrer en microscopie la présence de tissu endométrial.

Ça veut dire un tissu glandulaire cylindrique avec son corion cytotrophoblastique qui se trouve en dehors de la cavité de l'utérus. Sur le plan macroscopique, plusieurs lésions peuvent se voir. Vous allez voir ici que ces lésions peuvent être soit noirâtre, soit marron foncé, soit des papules glandulaires vascularisées, des lésions en flammèche, des ondes rouges hémorragiques, des pétéchies péritoniales, des adhérences péri-ovariennes.

Des déchirures péritoniales et des zones qui sont décolorées, marron, jaune, bleu, blanche. Pourquoi ça? Parce qu'il y a d'abord un saignement qui se fait au moment des règles et ce saignement qui va être rougeâtre au début, qui va associer une inflammation. L'inflammation peut cicatrifier ce qui va entraîner des adhérences, mais les zones qui sont rouges peuvent devenir marron, puis jaunâtre, ainsi de suite.

Donc c'est pour ça que vous allez trouver une multitude de lésions macroscopiques. Le plus souvent, vous allez trouver en cas d'endométriose des adhérences, mais également des lésions blanchâtres cicatricielles, des poches péritoniales causées par les adhérences, des lésions noirâtres, des vésicules claires, ainsi de suite. Donc beaucoup de lésions atypiques de l'endométriose.

Les localisations, la localisation la plus fréquente est la localisation au niveau du cul de sac de Douglas, mais également au niveau des ligaments larges, au niveau du ligament sacro-utérin,

ou ligament la vicié, l'ovaire, le fond de l'utérus, le cibouïde, l'étrante et le péritoine pariétal. Sur le plan clinique, la femme porteuse d'une endométriose, et ici je ne vais parler que de l'endométriose externe et non pas de l'adhénomiose. Donc je disais que la femme porteuse d'une endométriose va consulter par rapport deux grands syndromes, soit un syndrome douloureux chronique, soit un syndrome d'infertilité du couple.

Le syndrome douloureux comporte ce que j'ai appelé les quatre dés, les quatre douleurs, à savoir la dysménorrhée, c'est-à-dire les douleurs au cours des règles, la dyspareunie, ça veut dire les douleurs au cours du rapport sexuel, les douleurs pelviennes chroniques et la douleur à la défécation. La dysménorrhée est classiquement une dysménorrhée secondaire contrairement à la dysménorrhée essentielle où la dysménorrhée est primaire. Également contrairement à la dysménorrhée essentielle, la dysménorrhée engendrée par l'endométriose est une dysménorrhée qui survient à J2 voire J3 des règles, contrairement à la dysménorrhée essentielle où les dysménorrhées surviennent 2-3 jours avant les règles.

Deuxièmement, la dyspareunie profonde, ici également cette dyspareunie contrairement à la dyspareunie due en général à une lésion cicatricielle d'une épisiotomie qui est une dyspareunie superficielle dès l'intromission, la femme ressent une douleur, ici la dyspareunie est profonde parce que c'est une dyspareunie qui va survenir lors de la mise en tension des ligaments utérosacrés qui sont porteurs d'éventuels nodules endométriosiques. Troisième douleur, c'est la douleur pelvienne chronique ou algie pelvienne chronique, c'est des douleurs chroniques au niveau du pelvis et qui peuvent être cycliques, c'est-à-dire qui surviennent au cours des règles ou juste avant les règles, ou bien vous pouvez avoir une douleur pelvienne chronique en continu avec une exacerbation au moment des règles. Et troisième et quatrième douleur, c'est la douleur à la défécation très fréquente au cours de l'endométriose, c'est-à-dire lors de la défécation la femme ressent une douleur importante.

Le deuxième syndrome, c'est l'infertilité, c'est-à-dire un couple infertile qui va consulter et au cours de l'examen ou après examen complémentaire vous allez trouver qu'il peut s'agir d'une endométriose. Cette endométriose, cette infertilité au cours de l'endométriose peut être expliquée soit par l'obstruction des trompes due à une endométriose tubaire, soit une altération du pavillon tubaire, c'est-à-dire une soudure des franges pavillonnaires, ou bien par une dysovulation. Lorsque les ovaires sont porteurs de gros kystes endométriosiques, appelés également endométriomes, vous aurez une dysovulation, ça veut dire une anomalie de l'ovulation.

Ou bien cette infertilité au cours de l'endométriose peut être due à ce qu'on appelle le LUF syndrome, c'est-à-dire la lutéinisation du follicule sans qu'il y ait rupture. Donc il n'y a pas de rupture du follicule pour qu'il y ait la sortie de l'ovule, mais ici l'ovule va rester à l'intérieur du follicule qui va se lutéiniser et qui va se transformer en corps jaune. D'autres signes peuvent être associés, à savoir une hématurie lorsque l'endométriose est physique.

Cette hématurie est appelée hématurie cataméniale parce que c'est une hématurie qui va être au

moment des règles. Soit vous pouvez avoir un syndrome appendiculaire lorsqu'il y a une localisation au niveau de l'appendice et en général c'est comme l'appendicite et le plus souvent le diagnostic ne se fait qu'après une appendicectomie avec études anatomopathologiques. Vous pouvez avoir une diarrhée, des rectoragies lorsqu'il y a une localisation digestive et je vais parler un peu de l'adénomiose ici.

L'adénomiose en général c'est une patiente multipart proche de la ménopause qui va avoir soit des ménorragies, soit des ménométrorragies et qui va avoir des douleurs pelviennes chroniques et le diagnostic est fait par échographie ou par l'imagerie par résonance magnétique. Voilà un peu les principaux symptômes, une dysménorrhée, des douleurs pelviennes, une dyspareunie, des douleurs rectales, des hémorragies et une infertilité. L'examen clinique, d'abord vous allez examiner le périnée puisque vous pouvez avoir de la chance d'avoir une lésion endométriose au niveau du périnée ou au niveau de la veuve.

C'est des lésions en général bleuâtres ou rougeâtres que vous allez biotier et l'anapathe va vous répondre qu'il s'agit d'une endométriose, c'est-à-dire un tissu cylindrique associé à un chorion cytogène. Lorsqu'on met un spéculum pour voir le col et les cavités du vagin vous pouvez avoir des lésions bleuâtres ou rougeâtres de quelques millimètres, parfois des lésions hémorragiques. Le toucher vaginal est très important parce qu'il peut montrer des signes assez évocateurs.

Vous pouvez avoir un ou plusieurs modules douloureux au niveau du cul du sac de Douglas, une rétroversion utérine qui est fixée. Il y a deux types de rétroversion, il y a la rétroversion qui est anatomique, qui est normale, 25% des femmes ont un utérus rétroversé. Ici la rétroversion est secondaire, elle est due à des adhérences qui vont tirer l'utérus vers l'arrière et qui vont le fixer dans cette position.

Vous pouvez avoir un ou deux ovaires augmentés de volume par l'existence d'un kyste endométriosique au niveau de l'ovaire. Le toucher rectal, c'est pour explorer la cloison rectovaginale qui peut être le siège d'une nodosité endométriosique ou bien des modules au niveau du cul du sac de Douglas. Le reste de l'examen, parfois une masse sensible, ombilicale, en général en rapport avec une endométriose pariétale, un point douloureux urétéral dû à l'existence d'une endométriose urétérale, ainsi de suite.

Là où il y a d'autres localisations qui peuvent revêtir un aspect clinique particulier. Mais il faut savoir que le plus souvent l'examen clinique ne révèle qu'une douleur à la mobilisation de l'utérus et il est tout à fait normal. Les examens complémentaires, si on commence par une échographie, en général ici l'échographie devrait être endovaginale pour mieux explorer l'utérus et les ovaires.

Vous pouvez trouver une image latéro-utérine qui a une particularité d'avoir un contenu qui est homogène mais avec des échos de faible brillance qui sont répartis de façon uniforme. En général, si vous voyez la photo à droite, vous allez trouver qu'en haut il y a du liquide, en bas il y

a des lésions, des échos qui sont de faible brillance. En général, c'est un dépôt de ferritine, c'est du sang qui se cumule au niveau du kyste et qui va sédimenter et vous aurez en haut un aspect échographique anécogène et en bas un aspect finement écogène dû à la sédimentation.

L'hystérosympingographie, il faut dire que cet examen a diminué de sa valeur. Depuis l'ère de l'imagerie par résonance magnétique. Si vous demandez l'hystérosympingographie, vous allez trouver plusieurs lésions, des lésions tubulaires surtout proximales en boule de vie, des images d'ongulation de l'utérus, un utérus en parasol, une rétention de produits de contraste dû à des adhérences, un refoulement de la trempe par un éventuel kyste endométriosique ovarien.

Si vous voyez la photo à gauche, il y a une extravasation de produits de contraste dû à une fragilité de la paroi tubaire, il y a également une sténose distale de la trempe, il y a également un produit de contraste qui est aussitué dû à l'existence d'adhérence. À droite, vous avez surtout une extravasation de produits de contraste et des lésions au niveau de la trempe. Ici, vous voyez à gauche l'aspect en corne de taureau ou l'aspect en tuba erecta, ça veut dire que c'est une endométriose tubaire, il y a également une sténose tubaire à gauche et à droite, vous avez une extériorisation de produits de contraste et également il y a des diverticules au niveau de l'utérus.

Ici, vous pouvez regarder les flèches qui sont dues à une adenomyose, il y a également une endométriose tubaire, vous voyez à gauche, vous voyez la trempe gauche qui a une sténose distale. Ici, c'est un aspect diverticulaire d'une adenomyose et il y a également un tuba erecta, vous voyez que les trempes qui sont sténosées et qui se mettent en érection entre parenthèses, c'est assez évocateur d'une endométriose interne et externe, c'est-à-dire adenomyose et endométriose tubaire. L'examen du choix actuel est l'imagerie par résonance magnétique.

Cette imagerie par résonance magnétique est moins invasive que l'hystérosalpingographie et qui va vous donner non seulement le diagnostic de l'endométriose ou de l'adenomyose, mais également, il va vous montrer une cartographie des lésions pelviennes de l'endométriose. Sur le plan biologique, vous pouvez demander le CA 125, c'est un marqueur tumoral qui n'est pas pathognomonique, qui n'est pas spécifique de l'endométriose, mais qui peut s'avoir dans les tumeurs ovariennes, dans toute inflammation de pelvis. En principe, le plus souvent, pour avoir un diagnostic de certitude, il faut faire une sérieuse copie.

Il va vous permettre le diagnostic de la maladie en faisant des biopsies au niveau des lésions, et l'anapath va vous répondre qu'il s'agit d'un tissu endométrial. Il va vous montrer le bilan lésionnel et il va être le premier geste thérapeutique. Sur cette photo d'une échographie endovaginale, vous avez deux petites lésions anécogènes au niveau de la paroi de l'utérus.

Il y a également une irrégularité de la paroi de l'utérus, la paroi antérieure est petite par rapport à la paroi postérieure, ce sont des lésions dues à une adenomyose ou une endométriose interne. Ici, à la résonance magnétique, vous avez deux lésions d'une adenomyose. Ici, c'est une échographie oncorectale qui montre une lésion nodulaire, regardez bien la flèche, une lésion

nodulaire de la paroi digestive.

Et si vous faites la celluloscopie, vous allez voir des lésions, en général, ce sont des lésions qui sont rougeâtres, c'est une inflammation diffuse du pelvis avec des adhérences qu'on voit surtout sur la photo plus basse. Des lésions également au niveau de la cloison rectovaginale, ce sont des lésions qui sont hémorragiques, rougeâtres, que vous voyez en avant, c'est l'utérus et vous avez des lésions au niveau du cul de sac de Douglas, des lésions au niveau de la cloison rectovaginale. Ici, c'est des cystes endométriosiques ou des endométriomes, vous voyez l'ovaire et les cystes qui ont un caractère hémorragique.

Ici, c'est des adhérences entre l'utérus et les différents constituants du pelvis. Sur le plan thérapeutique, le but du traitement, puisque nous avons dit que la femme va consulter soit pour un syndrome douloureux, soit pour un syndrome d'infertilité de couple, soit l'association des deux. Donc, le but du traitement, c'est d'abord supprimer les douleurs de la femme et bien sûr, si possible, restituer la fertilité.

Comme moyen thérapeutique, vous avez l'abstention, c'est-à-dire si la femme ne présente pas beaucoup de symptômes, bon, c'est pas la peine de la mettre et s'il a des enfants, c'est pas la peine de la traiter. Il y a également l'hormonothérapie, soit les oestroprogestatives, c'est-à-dire la pilule. Les oestroprogestatives peuvent être données à la femme qui vont mettre au repos les ovaires et qui vont diminuer surtout la douleur.

Vous pouvez donner les progestatives, l'acétate de médroxyprogestérone, c'est des injections intramusculaires que vous faites. En général, c'est une injection d'acétate de médroxyprogestérone. Il a l'avantage d'être moins cher.

Il y a les progestatives de synthèse que vous pouvez donner par voie orale. Il y a le danazole, c'est un stéroïde anti-gonadotrope qui est efficace. Il est donné à 600 à 800 mg par jour.

Il est contre-indiqué en cas de diabète, en cas d'insuffisance rénale ou insuffisance hépatique, en cas d'hypertension artérielle et surtout en cas de grossesse. Il y a également les analogues de l'ALH RH qu'on doit donner. Ils sont très efficaces parce qu'ils vont engendrer une ménopause.

Je vous ai dit au début que c'est une pathologie de la femme en période d'activité génitale. Avec ce produit, ce médicament, vous allez entraîner une ménopause médicale. Il est très efficace, mais c'est une ménopause.

Il ne faut pas le donner plus de six mois, sinon vous aurez des complications de la ménopause, des complications de l'ostéoporose ou bien des complications cardio-vasculaires. Le traitement chirurgical repose sur la celluloscopie. On n'opère pas par la parotomie une femme porteuse d'une endométriose, c'est la celluloscopie.

Vous allez commencer par faire une adhésolise, c'est-à-dire enlever les adhérences. Puis vous

allez faire une exérèse des lésions, c'est-à-dire une exérèse de toutes les lésions endométriosiques. S'il y a une imperméation pubère, vous allez faire une reperméation de la trempe.

Il y a également un moyen thérapeutique, surtout pour les patientes qui consultent pour infertilité, c'est l'assistance médicale à la procréation. Les indications, si la femme consulte pour infertilité et n'a pas de douleur, donc si la forme est légère, commencez par une destruction des lésions endométriosiques lors de la celluloscopie qui a porté le diagnostic, c'est-à-dire la première celluloscopie. Et attendre, on peut attendre jusqu'à 18 mois.

S'il n'y a pas de grossesse, vous pouvez avoir recours à l'assistance médicale à la procréation, ou PMA, procréation médicalement assistée. Mais là également, ce n'est pas quelque chose de sûr, parce que c'est en fonction des patientes. Une patiente qui a 40 ans et qui a une endométriose et une infertilité, on ne va pas attendre chez elle 18 mois pour aller vers l'assistance médicale à la procréation.

Par contre, une femme qui a 22 ans et qui consulte pour une endométriose avec infertilité, dans ce cas, on a le temps d'attendre, donc on peut attendre 18 mois pour donner un traitement. Donc, c'est en général des discussions au staff médical pour dire quelles sont les femmes qui devraient subir une PMA et à quel moment on doit faire cette PMA. Dans les formes modérées à sévères, en général, on ne commence pas dans ces formes par une sélioscopie, parce que c'est un pelvis qui est inflammatoire, donc vous pouvez causer des complications chirurgicales.

C'est pour ça que vous pouvez commencer par engendrer une mélopause médicale en donnant les analogues LHRH ou GNRH pendant trois mois, puis on opère la femme par sélioscopie, puis on peut donner à la femme un traitement médical à base de progestatifs ou d'anazole. Et puis, s'il n'y a pas de grossesse, on va avoir recours à l'assistance médicale à la procréation. Si la femme consulte pour une douleur, dans ce cas, commencez par une sélioscopie, donnez des oestroprogestatifs, c'est une pilule, je dis bien, si la femme a des enfants, vous pouvez donner la pilule pendant neuf mois à un an, ça peut améliorer la clinique.

Surtout si il y a une douleur très importante, on peut également donner des analogues LHRH. En cas d'endomètre, c'est-à-dire des questions d'endométriose au niveau de l'ovaire, il faut les traiter chirurgicalement à condition que leur volume dépasse leur diamètre, dépasse les 6 cm. Des endomètres moins de 6 cm, il faut les respecter.

Bon, ici, vous avez un peu pourquoi la femme consulte, soit elle consulte pour de la douleur, et dans ce cas, si la douleur est légère ou modérée, vous pouvez traiter par les oestroprogestatifs ou bien par les progestatifs de synthèse. Si les formes sont modérées à sévères, commencez par une sérieuse copie diagnostique, faire une chirurgie des lésions, une excision des lésions, et après, vous pouvez donner le danazone, les oestroprogestatifs, les agonistes GnRH ou les progestatifs de synthèse. En cas de récurrence, donner un traitement médical qui peut aller jusqu'à

un an ou bien reprendre la femme pour traiter chirurgicalement.

L'ostéectomie, je ne suis pas d'accord, mais on peut avoir, si la douleur est très importante et la femme a des enfants, vous pouvez faire une ovariectomie bilatérale, chose qui se fait très, très, très rarement aujourd'hui. Si la femme consulte pour une infertilité, vous pouvez attendre de l'expectative pour voir est-ce que ça va marcher ou non. Bien sûr, il faut faire un bilan pour éliminer les autres causes d'infertilité.

Faire une sérioscopie diagnostique, faire une excision des lésions, et on va attendre entre 12 et 18 mois. S'il n'y a pas de grossesse, vous pouvez faire une simulation de l'ovulation ou bien une fécondation in vitro. Je vous remercie.